

Documento guía

ALIMENTACIÓN

SALUDABLE

Página | 2

Documento Guía Alimentación Saludable

Documento Guía

ALIMENTACIÓN SALUDABLE

Elaborado por:

Anyul Milena Vera Rey

Blanca C. Hernández T.

Subdirección Enfermedades No Transmisibles

Dirección de Promoción y Prevención

Ministerio de Salud y Protección Social

Asesoría Técnica

Luis Hernando Cepeda

Ingeniero de Alimentos, Magister en Administración en Salud

Profesional Centro para el Desarrollo y Evaluación de Políticas y Tecnología en Salud

Pública, CEDETES.

Universidad del Valle

Revisión:

Subdirección Enfermedades No Transmisibles – Ministerio de Salud y Protección Social:

Fernando Ramírez Campos, Ph.D

Lorenza Becerra

Convenio 451/2012, suscrito entre el Ministerio de Salud y Protección Social y la Universidad del Valle, a través del Centro para el Desarrollo y Evaluación de Políticas y Tecnologías en Salud Pública, CEDETES.

El contenido de este documento no puede ser citado, copiado o reproducido, parcial o totalmente, sin autorización expresa del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia.

Santiago de Cali, Marzo de 2013.

Página | 3

Documento Guía Alimentación Saludable

Documento Guía

ALIMENTACIÓN SALUDABLE

Tabla de contenido

I. Análisis de situación de salud de los factores relacionados con ENT 4

1. Alimentación Saludable

..... 4

1.1 Situación mundial	6
1.2 Situación de Colombia en la región	9
1.2.1 Análisis desde los Determinantes Sociales de la Salud	10
1.3 Situación en Colombia	14
II. Hoja de ruta	24
1. Estrategia de reducción de consumo de sal	24
2. Alimentación Saludable	29
3. Alimentación Saludable como parte de los EVS y la gestión de la atención de las ENT	33
3.1 Vivienda	34
3.2 Escuela-colegio hasta 5 de primaria	35
3.3 Universidad y otras instituciones de educación superior formal y no formal	36
3.4 Organizaciones laborales, empresas	37
3.5 Primera infancia	37
3.6 APS – Reorganización de los servicios de salud, gestión de riesgos para ENT	38
3.7 Necesidades de información	39
3.8 Información, educación y comunicación (IEC)	40
3.9 Autoridad sanitaria, IVC, normatividad	40
3.10 Asesoría y asistencia	41
3.11 Investigación, formulación y monitoreo de políticas	41
III. Indicadores	43
IV. Referencias	44

I.

Análisis de situación de salud de los factores relacionados con

Enfermedades No Transmisibles

1.

Alimentación Saludable

Las Enfermedades No Transmisibles (ENT) son la principal causa de enfermedad y muerte en el mundo y en Colombia; su elevada presentación está relacionada de manera amplia con factores de riesgo del comportamiento tales como una dieta no saludable (entendida como la ingesta elevada de grasas saturadas, sal, azúcares y dulces y un consumo insuficiente de frutas y verduras), la inactividad física, el tabaquismo y el consumo abusivo de alcohol.

La alimentación, como factor estructural, ha presentado en las últimas décadas modificaciones en sus patrones, asociadas a las transformaciones sociales y demográficas, que han sustituido la alimentación tradicional, basada en su mayor parte en alimentos de origen vegetal (cereales integrales, frutas, verduras de hoja, raíces y tubérculos, legumbres, frutos oleaginosos) por alimentos de alta densidad energética que incluye alimentos de elevado contenido en grasa total y grasas saturadas, azúcares refinados, refrescos y cereales que además son elaborados en complejos procesos industrializados; así mismo, es sabido que la población consume niveles de sal mucho más elevados que los recomendados para la prevención de enfermedades y que a nivel mundial, los más afectados por éste fenómeno son las poblaciones pobres que optan por opciones de alimentación más “baratas” siendo generalmente las menos saludables. Lo anterior, constituye en conjunto un factor de riesgo para el desarrollo de ENT como hipertensión arterial, hiperglucemia, hiperlipidemia, sobrepeso u obesidad, enfermedades cardiovasculares, cáncer y diabetes mellitus tipo II.

promoción y mantenimiento de una buena salud, lo que representaría una reducción sustancial de la mortalidad y la carga de enfermedad a nivel mundial. Las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, varios tipos de cánceres y la obesidad son algunas de las enfermedades que podrían prevenirse con un consumo adecuado de frutas y hortalizas-verduras, sumado a la práctica de actividad física regular.

En Colombia, la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional, ENSIN (ICBF, 2010) encontró que sólo el 20,5% de los colombianos consumen frutas 3 o más veces cada día y que únicamente 3 de cada 10 personas consumen todos los días verduras y hortalizas, de hecho, sólo el 6,4% lo hacen 2 o más veces. Lo que es más preocupante, es que el bajo consumo de frutas y hortalizas-verduras se agudiza en los estratos sociales bajos y en las zonas rurales donde paradójicamente se producen. La recomendación de consumo mínimo hecha por la OMS (Organización Mundial de la Salud) y la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) para prevenir enfermedades no transmisibles y mantener una buena salud es de 400 gramos entre frutas y verduras al día. Dado lo anterior, en 2004, la OMS adoptó la Estrategia Mundial sobre régimen alimentario, actividad física y salud, cuyos objetivos se orientan a: 1) reducir los factores de riesgo de ENT asociados a las dietas poco saludables y a la inactividad física a través de medidas de salud pública; 2) incrementar los conocimientos y concienciación acerca de la influencia de la dieta y la actividad física en la salud; 3) fortalecer las políticas y planes de acción mundiales, regionales y nacionales para mejorar la alimentación y, 4) seguir de cerca los datos que permitan monitorear el comportamiento de este factor en la morbilidad y mortalidad de las naciones (OMS, 2002) .

P á g i n a | 6

Documento Guía Alimentación Saludable

Como parte de las metas planteadas en ésta estrategia a nivel poblacional, con respecto a la alimentación (OMS, 2002), se presentan las siguientes

?

Lograr un equilibrio calórico y un peso saludable.

?

Reducir la ingesta calórica procedente de las grasas, cambiar las grasas saturadas por las insaturadas y eliminar los ácidos grasos trans.

?

Aumentar el consumo de frutas, verduras, legumbres, cereales integrales y frutos secos.

?

Reducir la ingesta de azúcares libres.

?

Reducir el consumo de sal (sodio), cualquiera que sea su fuente, y garantizar que la sal consumida esté yodada.

A partir de las anteriores premisas en materia de alimentación saludable, a continuación se presentan datos de importancia para el análisis de situación de salud en varios escenarios.

1.1. Situación mundial

Según el Informe sobre la Salud en el Mundo (OMS, 2002b), la carga de morbilidad es atribuible a factores de riesgo relacionados con la alimentación; señala que la hipertensión arterial, guarda relación directa con la ingesta de sal, la obesidad, el nivel de ejercicio físico y el consumo de alcohol. Como consecuencia de los efectos de esos factores la tensión arterial suele aumentar con la edad, excepto en las sociedades donde el consumo de sal es relativamente bajo, la actividad física es frecuente y la obesidad es casi

P á g i n a | 7

Documento Guía Alimentación Saludable

inexistente. La mayoría de los adultos tienen niveles inadecuados de tensión arterial, y esta situación es similar en los países en desarrollo y en los países desarrollados; no obstante, éste informe señala que en Europa los niveles de tensión arterial son especialmente altos. Sumado a lo anterior, indican que cerca de 7.1 millones de muertes ocurren a causa de la

hipertensión arterial, cifra que representa el 13% de la mortalidad total; aunque la mayoría de las muertes se producen en una edad avanzada o en el grupo de ancianos, las pérdidas de años de vida (AVAD) comprende una proporción menor del total mundial indicando 64,3 millones de AVAD, es decir, el 4,4% del total (OMS, 2002b).

Según el informe referido anteriormente, al igual que sucede con la tensión arterial, los riesgos derivados del colesterol elevado son continuos, pues se observan en casi todas las poblaciones, incluidas personas cuyo nivel de colesterol es muy inferior al observado en las poblaciones de América del Norte y Europa. Se estima que el colesterol alto ocasiona el 18% del total mundial de enfermedades cerebrovasculares y el 56% de las cardiopatías isquémicas. Es decir, aproximadamente 4,4 millones de muertes y 40,4 millones de AVAD perdidos en el mundo. En la mayoría de las regiones, la proporción de la mortalidad femenina atribuible al colesterol alto es ligeramente superior a la de la mortalidad masculina (OMS, 2002b).

Otros de los factores asociados a las ENT y relacionados con la alimentación, son el sobrepeso y la obesidad. Según la OMS, existe sobrepeso a partir de un índice de masa corporal (IMC) de 25 y obesidad a partir de un IMC de 30. Aunque estos son los valores de referencia, se considera que el riesgo de enfermedad aumenta en todas las poblaciones a partir de un IMC de 20-22 (18). En África y Asia el IMC observado ha oscilado entre 20 y 23, no obstante en la región de América del Norte y Europa éste índice se sitúa entre 25 y

P á g i n a | 8

Documento Guía Alimentación Saludable

27. El IMC aumenta en las personas ancianas con los consecuentes riesgos para la salud. El aumento en las prevalencias de obesidad se relaciona con el aumento en el consumo de los azúcares libres y de las grasas saturadas, y la baja actividad física, especialmente en zonas de América del Norte, el Reino Unido, Europa Oriental, las Islas del Pacífico y China. En los países en desarrollo la transición demográfica hace que el IMC aumente con rapidez, sobre todo entre los jóvenes. Se considera que el sobrepeso afecta a más de 1000 millones de adultos en el mundo y que cerca de 300 millones son clínicamente obesos (OMS, 2002b). Aproximadamente el 58% del total mundial de casos de diabetes mellitus, el 21%

de las cardiopatía isquémicas y entre el 8 y 42% de algunos cánceres son atribuibles a un IMC superior a 21; estas cifras representan aproximadamente el 13% de la mortalidad en Europa y el 9% de la mortalidad en América. La proporción de AVAD perdidos como resultado de un IMC alto es ligeramente superior en las mujeres que en los hombres (OMS, 2002b).

Finalmente, las frutas y verduras son componente indispensables para una alimentación sana. Según estimaciones de la OMS, 2.7 millones de muertes anuales en el mundo, son atribuibles a una ingesta insuficiente de frutas y verduras, lo que representa 26,7 millones de AVAD perdidos. Esta ingesta insuficiente, es uno de los 10 factores principales de riesgo de mortalidad a escala mundial. Así mismo, se calcula que la ingesta insuficiente de frutas y verduras causa en todo el mundo aproximadamente un 19% de los cánceres gastrointestinales, un 31% de las cardiopatías isquémicas y un 11% de los accidentes vasculares cerebrales (Ferlay, Shin, Bray, Froman, Mathera y Parkin, 2010; OMS, 2002b). El consumo actual estimado de frutas y verduras es muy variable en todo el mundo, oscilando entre 100 g/día en los países menos desarrollados y aproximadamente

P á g i n a | 9

Documento Guía Alimentación Saludable

450 g/día en Europa Occidental. Según el informe de la OMS y la FAO publicado recientemente se recomienda como objetivo poblacional la ingesta de un mínimo de 400 g/día de frutas y verduras (excluidas las patatas y otros tubérculos feculentos) para prevenir enfermedades crónicas como las cardiopatías, el cáncer, la diabetes o la obesidad, así como para prevenir y mitigar varias carencias de micronutrientes, sobre todo en los países menos desarrollados (OMS, 2013)

1.2. Situación de Colombia en la Región

Colombia ha experimentado una transición demográfica importante desde mediados del siglo XX. Para el período 2010–2015 se estimó una esperanza de vida al nacer de 75,2 años (78,5 para las mujeres y 72,1 para los hombres), una tasa bruta de mortalidad de 5,8 por 1.000 habitantes; una tasa bruta de natalidad de 18,9 por 1.000

habitantes y una tasa global de fecundidad de 2,4 hijos por mujer, lo que resulta en una tasa media anual de crecimiento de 1,15% (OMS, 2008).

Desde los años cincuenta la esperanza de vida aumento más de 20 años en Colombia, aunque persisten notables diferencias internas: por ejemplo, la esperanza de vida en Bogotá alcanza los 74,6 años y la de Chocó solo los 63,5 años; esta diferencia señala una inequidad importante en el acceso a los determinantes sociales de la salud. La esperanza de vida en las mujeres creció a un ritmo de tres años por década desde los años ochenta, aproximadamente. De otra parte, la esperanza de vida de los hombres, a causa de la violencia, avanzó más lentamente, a un ritmo inferior a los dos años por década. En 1950 la diferencia en la esperanza de vida al nacer entre Colombia y los Estados Unidos era de 22 años, en el 2005 fue inferior a 7 años.

P á g i n a | 10

Documento Guía Alimentación Saludable

La diferencia entre Colombia y los países más ricos también disminuyó en otros indicadores sociales, entre ellos la mortalidad infantil, la alfabetización y las coberturas de servicio públicos. La tasa de alfabetización, por ejemplo, pasó de 63% en 1950 a 93% en el año 2000. Esta progresión fue similar a la observada en otros países latinoamericanos como Brasil, México y Perú. Durante el periodo de análisis las tasas de alfabetización convergieron en América Latina (Astorga et al, citado por Gaviria, 2010). En 1950, la diferencia entre Colombia y Argentina ascendía a 27 puntos porcentuales. En el año 2000 se había reducido 5 puntos. En el mismo periodo las tasas promedio de alfabetización en América Latina se acercaron a las de Estados Unidos.

1.2.1. Análisis desde los Determinantes Sociales de la Salud

Entre 2000 y 2010 la economía ha mostrado un crecimiento sostenido. Las principales ramas de actividad son la minería, el comercio y la construcción. El crecimiento anual promedio del producto bruto interno (PBI) fue de 3,3% en el período 2006–2010, y PIB per cápita en 2009 llegó a US\$ 4.990 (dólares corrientes) o US\$ 8.600 per cápita ajustados según la paridad del poder adquisitivo. Este crecimiento enmascara corrupción,

precariedad del empleo y una desigualdad expresada por un coeficiente de Gini de 0,578 en 2009; en 2006, el 20% de la población más rica detentaba 24,8 más riqueza que el 20% de la población más pobre. Entre enero de 2006 y enero de 2010, el desempleo fluctuó entre 11,3% y 11,8%, pero el subempleo subjetivo se mantuvo entre 30,5% y 30,9%; el 75% de los que trabajaban lo hacían por cuenta propia. Entre 2005 y 2009, el porcentaje de población en condiciones de pobreza disminuyó de 50,3% a 45,5%, y el de población en pobreza extrema aumentó de 15,7% a 16,4%, que significa un avance leve hacia las metas

Página | 11

Documento Guía Alimentación Saludable

fijadas de 28,5% y 8,5% para 2015 en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (OMS, 2008).

El índice de Gini –que alcanza el 0,59 en Colombia-, recientemente confirmado por la Misión para el Empalme de las Series de Empleo, Pobreza y Desigualdad (MESEP), coincide con la apreciación de la CEPAL. Según las cifras del Índice de Desarrollo Humano (IDH), del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Colombia pasó a ser el país más inequitativo de Suramérica, con un índice de Gini de 0,585 para el 2009 y superó a Brasil y a Bolivia en los últimos tres años (MPS y UDEA, 2010). El desempleo nacional alcanzó la cifra de 9,3%, siendo 12,4% en la zona urbana y 7% en la zona rural. La brecha de desempleo, según sexo, es 7,0% para hombres y 12,5% para mujeres. Existen marcadas diferencias regionales, Bolívar tiene 8,1% y Nariño 22,2% (DANE, 2005).

El crecimiento económico y la consecuente distribución de la riqueza nacional, ha sido insuficiente como para disminuir las inequidades sociales internas. La evolución del ingreso por habitante en Colombia, desde comienzos de los años ochenta, ha sido similar a la de Perú y a la del promedio de los países emergentes. En Chile, Brasil y México, el ingreso por habitante creció a tasas más altas durante el mismo periodo. En términos generales el ingreso por habitante en esos países es, al menos, 50% superior al de Colombia. Un análisis comparativo de la evolución del ingreso per cápita de Colombia arroja varios hechos destacables: primero, la brecha económica entre Colombia y los países

desarrollados se ha mantenido, más o menos, inalterada durante los últimos cincuenta años; y segundo, la brecha con respecto a los países de América Latina se cerró durante los años

P á g i n a | 12

Documento Guía Alimentación Saludable

ochenta. Como consecuencia del mejor desempeño relativo de la economía colombiana durante la llamada crisis de la deuda (OMS, 2011).

La pobreza estructural ha disminuido de manera continua desde los años setenta y el número y la cantidad de bienes y servicios de consumo aumentó sustancialmente. La tasa de pobreza, medida como el porcentaje de hogares con una necesidad básica insatisfecha, y la de miseria, como el porcentaje de dos o más necesidades sin satisfacer, pasó entre 1973 y 2005 del 70% al 20%, y la de la miseria, del 45% al 6%. El avance fue continuo a pesar de los vaivenes de la economía y en particular de la crisis de fin de siglo.

Colombia como país en vía de desarrollo es sensible a la transición demográfica que trae consigo modificaciones importantes en los patrones de alimentación y en consecuencia afectan el comportamiento de la morbilidad y mortalidad por ENT.

Al revisar los perfiles de país para ENT presentados por la OMS (2011) el promedio de muertes proporcionales por este grupo de enfermedades en 2008, entre países como Estados Unidos, México, Cuba, Costa Rica, Colombia, Chile, Bolivia y Brasil es cercano al 76%, cifra que es ampliamente influenciada por países como Estados Unidos, Cuba y Chile donde la proporción de muertes por ENT es superior al 80%; entre tanto, países de las Américas como Bolivia y Colombia aportan el 57% y 66% al total de sus muertes respectivamente (Tabla 1).

En éste mismo informe sobre Perfil de Países, se presentan cifras relacionadas con los principales factores relacionados con las ENT; se muestra cómo la prevalencia de factores asociados con la alimentación, tales como el sobrepeso y obesidad, el colesterol y la glicemia aumentada presentan cifras alarmantes que requieren intervenciones prioritarias por parte de los gobiernos de los países señalados anteriormente.

P á g i n a | 13

Documento Guía Alimentación Saludable

En la tabla 1, se puede ver como la medición de prevalencia de sobrepeso representó para Colombia un 43.5% en hombres y un 52,7% en mujeres para el año 2008. Esta cifra nos ubica por debajo de las prevalencias para sobrepeso presentadas en países como Brasil, Chile, México, Costa Rica y Estados Unidos para el mismo año del reporte. No obstante, pone de manifiesto, que en Colombia aproximadamente uno de cada dos habitantes presenta sobrepeso.

Entre tanto, la obesidad aparece para el país como un problema latente, pues aunque las cifras de prevalencia son bajas en comparación con los otros países de la región analizados, constituyen una señal de alarma para el desarrollo de acciones de promoción y prevención en la población general (Tabla 1).

Con relación a la glucosa elevada, los Perfiles de Países de la OMS, indican para Colombia una prevalencia del 6% y 5,7% para hombres y mujeres respectivamente. Por otra parte, el colesterol elevado, las prevalencias reportadas corresponden al 40,8% y 41,8% en los hombres y mujeres respectivamente; esta cifra es muy similar en la totalidad de países incluidos en la tabla 1.

Fuente: Tabla elaborada a partir de: Organización Mundial de la Salud. Enfermedades No Transmisibles y Salud Mental. Enfermedades No Transmisibles: Perfiles de países 2011. Recuperado de <http://www.who.int/nmh/countries/es/index.html>

1.3. Situación en Colombia

La alimentación no saludable, como factor estructural en las últimas décadas ha presentado modificaciones en los patrones alimentarios asociados a las transformaciones económicas, sociales y demográficas, substituyéndose la alimentación tradicional basada en alimentos naturales por alimentos de alto contenido de grasa y alimentos elaborados. En las poblaciones urbanas, se ha modificado el régimen alimenticio a expensas del consumo de grasas y azúcares y la disminución del consumo de frutas y vegetales.

En Colombia, el 96% de las mujeres amamantó a sus niños al nacer; un 57% de ellas informó haber puesto al niño al seno en la primera hora de nacido, del 49% de lo reportado en la encuesta del 2005; 20% inició durante el primer día y 23% durante los primeros tres días de nacido. Persisten notables brechas en la iniciación de la lactancia materna en la primera hora de vida, según los entes territoriales y nivel educativo de la madre, siendo la lactancia más frecuente entre las mujeres más

Total ENT (%)

P revalencia de

Factores de riesgo %

(2008)

Hombres

M ujer es

Hombres

M ujer es

Hombres

M ujer es

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Glucosa elevada en sangre

6.0

5.7

9.7

9.6

-

-

11.1

10.0

11.8

13.0

12.3

13.7

9.4

9.7

13.8

10.9

Sobrepeso

43.5

52.7

52.4

51.0

39.3

57.3

64.3

66.2

48.6

60.2

67.3

69.3

59.4

57.2

73.5

68.2

Obesidad

11.3

22.9

16.0

21.4

9.6

25.9

24.6

34.0

13.7

29.2

26.3

37.4

20.4

27.1

31.1

34.8

Colesterol elevado

40.8

41.8

43.0

42.6

-

-

49.0

49.1

-

-

47.1

51.6

37.1

43.6

53.3

56.9

Mortalidad proporcional (% del total de defunciones, todas las edades)

66

74

57

83

84

78

80

87

Costa Rica

Estados Unidos

Componente de
análisis

América del Sur

América central

América del Norte

Colombia

Brasil

Bolivia

Chile

Cuba

México

Página | 15

Documento Guía Alimentación Saludable

educadas, que recibieron cuidados en salud durante la gestación. El porcentaje de niños con lactancia exclusiva desciende del 63% en los dos primeros meses de vida al 24% a los cuatro meses de vida. La duración de la lactancia materna exclusiva fue muy corta, con una mediana de 1,8 meses y la lactancia materna predominante, entendida como lactancia materna exclusiva complementada con líquidos no lácteos fue, en promedio, de 2,7 meses; cifras que distan de las recomendaciones internacionales.

Entre los niños y niñas amamantados se observa que antes de los seis meses ya se ha iniciado la introducción de otros líquidos y alimentos, tales como el uso de leche de fórmula infantil en un 33,2%. Esta práctica, junto al uso de biberón, va en aumento, pues pasó del 40% en el 2005, al 45% en el 2010, lo que suele desestimular la práctica de la lactancia exclusiva durante los primeros seis meses de vida del recién nacido. La alimentación complementaria se realiza precozmente y la calidad de la dieta es desbalanceada, especialmente en el grupo de edad entre los 6 y 8 meses.

Existe un cuerpo de evidencias que destacan la relación entre la mala nutrición,

la génesis de la aterosclerosis y la enfermedad coronaria. Alta y frecuente ingesta de grasas saturadas, grasas trans y sal, junto con un bajo consumo de frutas, verduras y pescado, han sido asociados con un alto riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares (OMS, 2011b).

Con relación a los patrones de consumo predominantes en nuestro país, según la Encuesta de Situación Nutricional, ENSIN, 2010, en la población entre 5 y 64 años, 1 de cada 3 colombianos no consume frutas diariamente; el 71,9% de los colombianos no consume verduras ni hortalizas diariamente; aproximadamente 1 de cada 4 consume comidas rápidas semanalmente, y lo hace el 34,2% de los jóvenes entre 14 y 18 años;

P á g i n a | 16

Documento Guía Alimentación Saludable

además, 1 de cada 5 consume bebidas gaseosa azucaradas diariamente, 1 de cada 7 consume alimentos de paquete diariamente, siendo los niños y adolescentes quienes presentan una mayor frecuencia de consumo de estos alimentos; 1 de cada 3 consume golosinas y dulces diariamente. El 32% de la población consume alimentos fritos diariamente, el 39.5% consume alimentos manipulados en la calle.

En zona urbana el 60% de la población consume comidas rápidas en el mes, en la zona rural este porcentaje es de 19.8% y el 16.7% de los colombianos adiciona mas sal a los alimentos después de servidos en la mesa.

La obesidad es un problema creciente de salud pública en países desarrollados y en desarrollo. La obesidad es un factor de riesgo cardiovascular relacionada con la dieta e inactividad física. La obesidad aparece como consecuencia de un desequilibrio entre el consumo de energía y el gasto de la misma. El consumo frecuente de alimentos de alta energía, tales como los alimentos procesados con alto contenido de grasas y azúcares, promueve la obesidad en comparación con el consumo de alimentos bajos en energía. La dieta saludable suele contribuir a un peso saludables, un perfil lipídico deseable y una presión arterial estable (OMS, 2011b).

A nivel mundial, al menos 2,8 millones de personas mueren cada año como resultado de tener sobrepeso u obesidad y se estima que un 35,8 millones de los AVAD

mundiales (2,3%), son causados por el sobrepeso o la obesidad. En el 2008, el 34% de los adultos mayores de 20 años de edad tenían sobrepeso, con un índice de masa corporal (IMC) mayor o igual a 25 kg/m² (33,6% de los hombres y 35% de las mujeres). En ese mismo año, 9,8% de los hombres y 13,8% de las mujeres eran obesas

P á g i n a | 17

Documento Guía Alimentación Saludable

(IMC mayor o igual a 30 kg/m²), frente al 4,8% de hombres y 7,9% de mujeres en 1980, lo cual señala un franco aumento en la obesidad.

El riesgo de sobrepeso, entre una y dos desviaciones estándar para Colombia en el 2010 fue de 20.2% en niños de 0-4 años; 18,9% en niños de 5-9 años, de 16.7% en niños de 10 a 17 años. Realizando el comparativo de las dos últimas encuestas (2005-2010) en niños de 0-4 años pasó de 4,9% a 5,2%, mientras que en el grupo de menores de un año (5,7%- 4,9%) y en el grupo de 2 años (5.6%-4,5%) se observa tendencia a la disminución; para el grupo de niños y niñas de 5 a 9 años en el 2010 la prevalencia fue de 5,2% y en el grupo de 10 a 17 años la prevalencia fue de 3,4%.

Gráfica No. 5.

Gráfica No. 6.

Fuente: ENSIN 2005-2010

De acuerdo a los resultados de la ENSIN 2010 (ICBF, 2010) con respecto a 2005, el sobrepeso (IMC, mayor o igual a 25 y menor o igual a 30) en el grupo de 18 a 64 años aumentó en promedio 2 puntos porcentuales; la obesidad (IMC > A 30 años) en el grupo de 18 a 64 años aumentó en promedio 2,5 puntos % en el 2010 con respecto al 2005. El riesgo de sobrepeso, obesidad y exceso de peso en la población de 14 a 64 años muestran una tendencia al aumento, lo cual sugiere cambios negativos en los patrones de consumo.

Página | 18

Documento Guía Alimentación Saludable

Gráfica No. 7.

Fuente ENSIN 2005 - 2010

Está demostrado que tanto el retraso del crecimiento como un aumento excesivo del peso en la infancia, contribuyen a la incidencia posterior de enfermedades crónicas. El retraso de crecimiento en talla en la niñez también se asocia a un mayor riesgo de cardiopatía coronaria, accidente cerebrovascular y, hasta cierto punto, diabetes. El riesgo de sufrir varias enfermedades crónicas de la niñez y la adolescencia, también se ha asociado a la alimentación del lactante con sucedáneos de la leche materna y con una lactancia materna breve.

La misma Encuesta Nacional de la Situación Nutricional de Colombia encontró anemia en 47,4% de los niños prescolares, 40,9% de las mujeres en edad fértil y 44,7% de las embarazadas; retinol sérico inferior a 20 ug/dl en 5,9% de los menores de 5 años, y deficiencia de zinc en 26,9% de los niños de 1 a 4 años (ICBF, 2010).

En Colombia, la información referente al comportamiento de los factores de la alimentación que guardan relación con el desarrollo de ENT, ha sido obtenida a partir de grandes encuestas poblacionales entre ellas, las más relevantes para el tema han sido la

Encuesta Nacional de la Situación Nutricional en Colombia (ENSIN) realizada en 2005 y

Página | 19

Documento Guía Alimentación Saludable

posteriormente en 2010 (ICBF, 2010). A partir de éstas se han obtenido conclusiones que han motivado el desarrollo de acciones en salud pública.

Según resultados de la ENSIN 2010, en el capítulo relacionado a las prácticas de alimentación de interés en nutrición y salud pública, se identificaron varios aspectos relacionados con el futuro desarrollo de ENT.

Por ejemplo, que en la población de 5 a 64 años, 1 de cada 3 colombianos no consume frutas diariamente, siendo el grupo de edad entre 31 y 64 años el que menor frecuencia de consumo de frutas reporta. En la población del nivel 1 del SISBEN (Sistema de Identificación de Beneficiarios) este porcentaje es del 41,2%. En general, las mujeres tienen mayor consumo de frutas que los hombres y la frecuencia diaria es mayor en las áreas urbanas que en las rurales. Las regiones con menor consumo diario de frutas en Colombia son Amazonia y Orinoquia y Región Central.

Con relación al consumo de verduras y hortalizas, la ENSIN indicó que el 71,9% de los colombianos no consume verduras y hortalizas diariamente; siendo mayor el porcentaje de no consumo entre los menores de 18 años donde el 75% de los jóvenes no consume estos alimentos. Al igual que en las frutas, las mujeres consumen más verduras y hortalizas que los hombres. Los departamentos de la región Central son los que menor consumo diario de verduras y hortalizas reportaron.

En contraposición, los alimentos procesados, como los embutidos (salchichas, salchichón, jamón, mortadela), considerados además alta fuente de sodio, son consumidos por el 73,6% de la población entre 5 y 64 años de forma semanal. Los niños y jóvenes de 9 a 18 años reportaron un mayor consumo de embutidos diario y semanal; a su vez el consumo es mayor en las áreas urbanas. Esto guarda relación con mayor disponibilidad de

Página | 20

Documento Guía Alimentación Saludable

los productos en los mercados. Los alimentos de paquete también hacen parte de la

alimentación de los colombianos, identificando que el 69,6% de los encuestados los consume, de éstos el 15,2% los consume a diario y el 45,5% los consume de forma semanal; estos alimentos son preferidos por los niños y adolescentes. Sumado a lo anterior, las comidas rápidas también se identificaron como parte del menú de los colombianos, siendo consumidas por al menos el 25% de la población cada semana, se encontró que a mayor nivel socioeconómico aumenta el consumo de comidas rápidas en Colombia.

Dado lo anterior, se identifica que la adición de sal en la mesa no es el único problema. En gran parte de la población, la mayor cantidad de sal en la dieta proviene de los platos preparados, alimentos precocidos, incluyendo el pan, carnes procesadas, e incluso cereales para el desayuno.

Adicionalmente, las bebidas de tipo gaseosa y refrescos son consumidas por 1 de cada 5 colombianos por lo menos una vez al día. Las golosinas y dulces son consumidos por al menos el 30% de la población cada día, así mismo, los fritos están presentes en el menú diario del 32% de los colombianos. En las zonas urbanas el 60% de la población ingiere comidas rápidas en un mes usual, en las zonas rurales esta cifra es menor con el 19,8% de la población.

Otro de los factores de riesgo señalados es el consumo de sal aumentado, donde la encuesta reportó que al menos el 16,7% de los colombianos adiciona más sal a los alimentos luego de servidos en la mesa. Bogotá es la región donde en mayor proporción se realiza esta práctica con el 21,3%, seguida por la región oriental con el 20,1% y la pacífica con el 17,5% de la población encuestada (ICBF, 2010).

P á g i n a | 21

Documento Guía Alimentación Saludable

Con relación al sobrepeso y obesidad, la misma encuesta informó que en los niños y adolescentes de 5 a 17 años, la prevalencia de éste factor de riesgo aumentó en un 25,9% en el último quinquenio. En otros términos, informa que uno de cada seis niños y adolescentes presenta sobrepeso u obesidad, esta relación aumenta a medida que se incrementa el nivel del SISBEN y el nivel educativo de la madre (9,4% en madres sin

educación vs 26,8% en madres con educación superior). El exceso de peso en este grupo de edad es mayor en el área urbana con 19,2% que en el rural con 13,4%. Los departamentos con mayores prevalencias de sobrepeso u obesidad fueron San Andrés con 31,1%, Guaviare con 22,4% y Cauca con 21,7%.

En los adultos entre 18 y 64 años, la ENSIN 2010, indicó que la prevalencia de sobrepeso está presente en uno de cada dos colombianos. Estas cifras aumentaron en los últimos cinco años en 5,3 puntos porcentuales, en 2005 el valor fue de 45,9% pasando a 51,2% en 2010. El exceso de peso es mayor en las mujeres que en los hombres con 55,2% frente a 45,6% respectivamente. Aunque en todos los niveles del SISBEN la prevalencia de sobrepeso y obesidad es alta, los niveles más altos de la clasificación SISBEN superan el 45% de la prevalencia. La mayor prevalencia del exceso de peso se presenta en el área urbana con el 52,5%, superando así el promedio nacional. Los departamentos con mayor prevalencia de exceso de peso con San Andrés y Providencia con el 65%, Guaviare con el 62,1%, Guainía con el 58,9%, Vichada con el 58,4% y Caquetá con el 58,8%.

La obesidad abdominal calculada por la circunferencia de la cintura en la población entre 18 y 64 años, como otro de los factores de riesgo para ENT relacionados con la alimentación, especialmente para Enfermedades Cardiovasculares, también fue evaluada mediante la ENSIN, sus resultados indicaron que este indicador es mayor en las

P á g i n a | 22

Documento Guía Alimentación Saludable

mujeres de todos los grupos de edad pero sobresalen las mujeres entre 18 y 29 años. Los hombres del área urbana presentaron mayor prevalencia de obesidad abdominal comparados con los hombres del área rural. Finalmente se obtuvo, que al menos uno de cada dos hombres de los departamentos de Guaviare, San Andrés y Providencia y Arauca tiene obesidad abdominal. Para las mujeres, los departamentos de mayor prevalencia de obesidad abdominal fueron Tolima, San Andrés y Providencia, Cundinamarca y Arauca (ICBF, 2010)

En conclusión, Colombia atraviesa por un período de transición demográfica en el que a nivel de alimentación y nutrición se presentan déficit y excesos, a pesar de los

esfuerzos realizados por el gobierno para su control. Por lo anterior, el panorama nacional en materia de alimentación lleva a reflexionar y genera la necesidad de definir políticas públicas orientadas a promover la alimentación saludable, contemplando escenarios intersectoriales, y abordando la problemáticas desde el enfoque de determinantes sociales.

PND,
Política
Nal.
CONPES
113,
PNSAN,
PDSP
2013-2021
Plan sectorial de
Salud
Plan estratégico
intersectorial
Incidencia política
y procesos de
movilización
Social

Servicios o
programas para la
promoción

Gestión del
conocimiento

Fortalecimiento
entornos

Procesos de
gobernanza y
rectoría

Cambio positivo de
los entornos

Personal sanitario
formado bajo la
estrategia de APS
implementando

EVS.

Cambios en
conocimientos,
actitudes y
prácticas/
participación
comunitaria

MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Instrumentos

Intervención	Resultado
--------------	-----------

MARCO REFERENCIAL, NORMATIVO Y LEGAL

CONTEXTO NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL

Componentes para estructurar la acción en

II. HOJA DE RUTA

1. Estrategia de Reducción del consumo de sal.

PROCESO

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

ACTORES

INVOLUCRADOS

METAS

A CUAL PLAN

RESPONDE

Formulación

de la

Estrategia de

reducción de

sodio

Elaboración del documento

técnico de la estrategia.

Ministerio,

Industria

Industria

Alimentaria,

Academia,

Sociedad Civil,

INS, Invima,

OPS,

CDC,

CEDETES

Documento que contenga
la estrategia de reducción
de sal formulado

Plan Sectorial

Plan Regional

de Enfermedad

cardiovascular

Reducción de

sal en los

alimentos

procesados

Priorizar

alimentos

procesados para la reducción

del contenido de sodio.

Ministerio,

Industria de Alimentos

Industria

de

alimentos,

Academia

Alimentos

priorizados

para la reducción del

contenido de sodio.

Conformar las mesas de

trabajo para cada grupo de

alimentos

procesados

priorizados

(Embutidos,

snacks, quesos, pan).

Grupo de industria

Industria,

Invima,

INS, Ministerio

Mesas

de

trabajo

conformadas

Definir la metodología de

trabajo

para

las

mesas

conformadas.

Ministerio/ ANDI

Industria- Ministerio

Metodología de trabajo

para

las

mesas

conformadas.

Elaboración

del

marco

normativo que oriente las

Invima,

INS,

Ministerio

Invima,

INS,

Ministerio

Acto

normativo

que

regule.

P á g i n a | 25

Documento Guía Alimentación Saludable

prácticas sanitarias en la

reducción del contenido de

sodio

en

alimentos

procesados.

Fijar objetivos, metas, plazos

de reducción del contenido

de

sodio

de

alimentos

procesados priorizados

Ministerio,

Industria de Alimentos

INS, Invima (grupo de

Industria

Industria

de

alimentos

INS, INVIMA

Objetivos, metas y plazos

de

reducción

del

contenido de sodio en

alimentos priorizados.

Convocar y sensibilizar a la

industria

del

catering,

restaurantes y escuelas de

gastronomía para promover

su

participación

en

la

estrategia.

Grupo de industria y

Grupo IEC

Restaurantes,

escuelas

de

gastronomía,

industria

del

catering, Ministerio,
Secretarías de Salud
Restaurantes, escuelas de
gastronomía e industria
del catering informados y
sensibilizados frente al
tema

Definir con la industria del
catering,
restaurantes

y
escuelas
de

gastronomía,
plan de trabajo del sector
para

la
disminución
del

contenido
de

sodio
en

preparaciones

y
para

la
creación

de

un
entorno
favorable
para
la
disminución del consumo de
sodio
Grupo de Restaurantes
Restaurantes,
escuelas
de
gastronomía,
industria
del
catering, Ministerio,
Secretarías de Salud,
consumidores

Plan de trabajo formulado

P á g i n a | 26

Documento Guía Alimentación Saludable

Difusión e implementación
del plan de trabajo formulado
para restaurantes, industrias
de catering y escuelas de
gastronomía

Grupo de Restaurantes
Restaurantes,
escuelas
de

gastronomía,

industria

del

catering, Ministerio,

Secretarías de Salud,

consumidores

Plan de trabajo formulado

y difundido

Sistema de

Monitoreo

Desarrollo de un sistema de

monitoreo del desarrollo de

la estrategia.

INVIMA, INS, MSPS

INVIMA,

INS,

MSPS

Indicadores de proceso y

de resultados evaluados.

Plan

comunicación

l

Elaboración de un marco de

armonización

de

responsabilidades

de

los

actores participantes en los

diversos escenarios.

Invima,

INS,

Ministerio

Invima,

INS,

Ministerio

Esquema de competencias

y responsabilidades en los

sectores

de

educación,

organizaciones de trabajo,

salud y comunitario, entre

otros.

Elaborar

un

plan

comunicacional para difundir

la estrategia de reducción del

consumo de sodio para la

población Colombiana

Grupo IEC

Entidades

gubernamentales, no

gubernamentales,

redes

sociales,

población en general

Plan

comunicacional

formulado

P á g i n a | 27

Documento Guía Alimentación Saludable

Contribuir

con

la

construcción

de

las

herramientas

(brochure,

mensajes

claves,

afiches

plegables) para organizar una

campaña de percepción del

riesgo

por

parte

de

la

población relacionada con

los

efectos

del

excesivo

consumo de sodio.

Grupo de IEC, Oficina

de

Comunicaciones

del Ministerio

Grupo IEC, Sociedad

Civil, EPS, IPS.

Herramientas elaboradas

Implementar

el

plan

de

comunicaciones formulado

Grupo IEC

Grupo IEC, sociedad

civil, organizaciones

estatales, secretarias

de salud, EPS, IPS.

Plan de comunicaciones

en implementación

Evaluación del

plan de medios

Evaluar los mecanismos de

divulgación y comunicación

en la población general.

Grupos IEC

Grupo IEC, sociedad

civil, organizaciones

estatales, secretarias

de salud, EPS, IPS.

Resultados de evaluación:

Cambios

en

conocimientos, actitudes

y prácticas.

Investigación

Elaborar los protocolos e

instrumentos para determinar

la línea de base del consumo

de sodio

Universidad

de

Antioquia,

Dirección

de

Epidemiología,

Subdirección ENT

Universidad

de

Antioquia, Dirección

de

Epidemiología,

Subdirección

ENT,

grupo

de

investigación de la

estrategia.

Productos

pactados

recibidos a satisfacción

Gestionar

investigación

relacionada con el desarrollo

Grupo

de

Investigación

de

la

Academia,

INS, Métodos

y

aditivos

identificados

y

P á g i n a | 28

Documento Guía Alimentación Saludable

de

métodos

nuevos

de

producción de alimentos y

utilización de aditivos para

disminuir el contenido de

sodio

de

alimentos
procesados.
estrategia
INVIMA, Ministerio
documentados
Buscar y evaluar información
relacionada
con
metas,
objetivos
y
plazos
de
reducción
en
alimentos
priorizados
Grupo
de
Investigación
Academia,
INS,
Ministerio
Objetivos, metas y plazos
de
reducción
del
contenido de sodio en
alimentos

priorizados
documentados.

Nota: El grupo de industria y restaurantes está conformado actualmente por empresas afiliadas a la ANDI, representantes de la

Academia, Invima y Ministerio de Salud y Protección

El grupo de IEC: Está conformado por la academia, sociedad civil, industria, Ministerio de Salud y Protección Social, ICBF.

El grupo de Investigación está conformado por el INS, Ministerio y Academia.

P á g i n a | 29

Documento Guía Alimentación Saludable

2. Alimentación Saludable

PROCESO

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

ACTORES

INVOLUCRADOS

METAS

A CUAL

PLAN

RESPONDE

Plan

Comunicacional

Incluir en el plan comunicacional

institucional todos los temas de

alimentación saludable: equilibrio

calórico y un peso saludable,

promoción del consumo de frutas y
hortalizas, reducción de la ingesta
calórica
procedente
de
grasas,
cambio de grasas saturadas por
insaturadas y eliminar las grasas
trans, reducción de la ingesta de
azúcares libres, reducir el consumo
de sodio.

Ministerio

Subdirección de ENT,

Oficina

de

Comunicaciones

Contenidos

técnicos

elaborados y aprobados

por

la

Oficina

de

Comunicaciones.

Construir un plan de medios donde
se desarrolle la estrategia de
promoción al consumo de frutas y
verduras,

teniendo
en
cuenta
factores
relacionados
con
la
producción, y el consumo, de
acuerdo al lineamiento técnico
nacional.

Ministerio, FAO

Subdirección de ENT,

Oficina

de

Comunicaciones

MSPS y FAO

Contenidos

técnicos

elaborados y aprobados.

Medios

masivos

y

comunitarios

identificados.

Construcción de

documentos

Construcción de lineamientos para

la promoción del consumo de frutas

FAO -Ministerio.

Convenio

389-

Min

Agricultura,

Mincomercio,

Asociaciones

de

Lineamiento construido

P á g i n a | 30

Documento Guía Alimentación Saludable

técnicos

hortalizas en los diferentes entornos

2012

productores

Construcción

de

documentos

regionales de plan de acción,

divulgados

y

validados,

que

garanticen

la

aplicación

con

enfoque

diferencial

en
los
territorios,
del
lineamiento
nacional.
Ministerio FAO
Ministerio
de
Agricultura
y
Desarrollo Rural,
Ministerio
de
comercio Industria y
Turismo, Ministerio de
Cultura,
Entidades
Territoriales
Plan de acción construido
validado y en ejecución

Documento
técnico
de
Lineamientos para alimentos y
bebidas expendidos en tiendas
escolares y las vías posibles, para la
reglamentación correspondiente.

Ministerio, OPS

Ministerio

de

Educación,

ICBF,

Ministerio de Salud,

ICBF.

Lineamientos

para

alimentos

y

bebidas

expedidos

en

tiendas

escolares formulados.

Ley 1355 de

2009

Documento técnico que contenga el

marco normativo y requisitos que

deben cumplir los alimentos que se

adquieren por parte del estado para

asegurar el suministro de una

alimentación saludable.

Ministerio

Ministerio

Documento construido

Ley

1335

Plan regional
de
enfermedad
cardiovascul
ar
Coordinación
Intersectorial
Apoyo
a
la
concertación
e
implementación de los estándares
de alimentación escolar
Ministerio salud,
Ministerio
de
Educación
e
ICBF, DNP
Ministerio
de
Educación, Ministerio
de Salud
Estándares
de
alimentación escolar para
el
entorno

escolar

concertados

e

implementados

Ley 1355 de

2009

P á g i n a | 31

Documento Guía Alimentación Saludable

Apoyo a la consolidación de la

mesa nacional intersectorial para la

promoción del consumo de frutas y

verduras.

Ministerio Salud,

FAO, Ministerio

de

Agricultura,

Ministerio

de

Educación

MSPS, FAO, MADR,

MINCOMERCIO,

MINCULTURA,

MINEDUCACIÓN

Mesa

conformada

con

planes

de

acción

intersectoriales,
concertados y definidos

Apoyo a la
construcción e
implementación
de la
normatividad

Gestionar
la
concertación
del
acuerdo de responsabilidad social
empresarial
con
la
industria
relacionado con la producción y
comercialización
de
alimentos
procesados saludables.
Ministerio,
Industria

de

alimentos

Ministerio de Salud,

Industria

de

Alimentos,

Sociedad Civil

Documento que contenga

las acciones desarrolladas

para la concertación del

Acuerdo

de

responsabilidad

social

empresarial construido y

concertado en el marco de

alimentación saludable

Ley 1355 de

2009

Apoyo a la Subdirección de Salud Nutricional Alimentos y Bebidas

Ley 1355 de

2009

Apoyo técnico a la revisión de la

Resolución 333 de 2011.

Ministerio

Ministerio

Documento

con

los

aportes a la Resolución

333 de 2011.

Apoyo técnico a la formulación de
un reglamento relacionado con la
publicidad en alimentos dirigida a
niños

Ministerio

Ministerio

Documento que contenga

los aportes al reglamento

relacionado

con

la

publicidad de alimentos

dirigida a niños

Asistencia

técnica

Difundir normatividad y brindar
asesoría técnica en su aplicación.

Ministerio

Ministerio,

Normatividad difundida

P á g i n a | 32

Documento Guía Alimentación Saludable

Entidades territoriales

Asesoría técnica realizada

Acompañar el proceso regional de
implementación del lineamiento
técnico nacional para la promoción

al consumo de frutas y verduras

MSPS - FAO

MSPS,

FAO,

Entidades territoriales

en Salud

Documento que contenga

las

actividades

de

acompañamiento

y

capacitación

a

los

territorios.

Difundir

herramientas

para

la

promoción

de

alimentación

saludable (Notas técnicas, videos,

documentos técnicos, afiches, guías

de orientación, recursos virtuales)

Ministerio

Ministerio

Entidades territoriales

Herramientas
de
promoción
de
alimentación
saludable
enviadas a las entidades
territoriales
Capacitación
en
aplicación
de
normas.
Ministerio
Ministerio – Entidades
territoriales
Socialización
de
la
aplicación
de
normas
difundida
Plan
Sectorial de
salud
Capacitación y asesoría para la
implementación de estrategias

Plan sectorial

de Salud

Capacitación en la adopción de

metodologías para la gestión y

articulación intersectorial

Ministerio

Ministerio – Entidades

territoriales

Socialización

de

la

adopción de metodologías

para

la

gestión

y

articulación intersectorial

Fortalecimiento de la capacidad

técnica en los territorios para la

adopción de los planes, programas

y estrategias en los diferentes

entornos priorizados.

Ministerio

Ministerio, Entidades

territoriales

Socialización de planes,

programas y estrategias

aplicadas a los diferentes
entornos priorizados

P á g i n a | 33

Documento Guía Alimentación Saludable

3. Alimentación saludable como parte de los estilos de vida saludable (EVS) y la gestión de la atención de las Enfermedades No Transmisibles

Objetivo general:

Fomentar el consumo de una alimentación (saludable) como parte de los estilos de vida saludable en la población colombiana en los diferentes entornos que constituyen una apuesta estratégica para el sector mediante la implementación de diferentes líneas de acción que plantean el desarrollo de actividades que requieren de articulación del sector salud con los sectores en donde se desarrolla la vida cotidiana de la población.

Con el fin de promocionar la salud y prevenir la enfermedad en los diferentes ámbitos las medidas saludables que se propone implementar incluyen:

- a. Lograr un equilibrio calórico y un peso saludable.
- b. Reducir la ingesta calórica procedente de las grasas, cambiar las grasas saturadas por las insaturadas y eliminar los ácidos grasos trans.
- d. Aumentar el consumo de frutas, verduras, legumbres, cereales integrales y frutos secos.
- e. Reducir la ingesta de azúcares libres.
- f. Reducir el consumo de sal (sodio), cualquiera que sea su fuente, y garantizar que la sal consumida esté yodada

3.1 VIVIENDA

LINEAS DE ACCION

ACTIVIDADES

Interacción intersectorial para el
acceso

a

servicios

públicos

e

infraestructura

Identificar los sectores involucrados

Orientación de las Direcciones Locales de Salud hacia
los determinantes de ENT.

Gestión para la implementación de los lineamientos en
alimentación saludable.

Promoción de EVS

Identificación de creencias y prácticas de grupos
diferenciales y adaptación de medidas de promoción de
alimentación saludable

Adopción de contenidos a partir de documentos nacionales
e internacionales sobre el tema de alimentación saludable
(Reducción del consumo de sal, promoción del consumo de
frutas y verduras, disminución del consumo de grasas trans)

Difusión y capacitación a familias a través de actores clave

(Red Unidos, ICBF, acciones PIC, EPS, etc.)

Fomento del consumo de frutas y hortalizas a los integrantes de la familia, por parte de los equipos básicos APS y a través de las acciones PIC

Prevención

de

riesgos

para

el

desarrollo de enfermedades crónicas

no

transmisibles

asociadas

al

consumo de una alimentación no saludable.

Difusión del ABC del sodio (nota informativa al consumidor) a través de las EPS, IPS, Secretarías de salud

Gestión para la implementación alimentación saludable en AIEPI comunitario

Campañas de percepción del riesgo respecto al consumo de una alimentación con un contenido excesivo de sodio, grasas trans, azúcares añadidos entre otros y de controles periódicos para lograr un peso saludable.

Elaboración, de un boletín que contenga los derechos y deberes de las familias para acceder a consejería nutricional en temas de alimentación saludable.

Fortalecer las capacidades de grupos organizados de mujeres y voluntariados como promotoras de la nutrición y

alimentación saludable.

Fortalecimiento de capacidades locales para identificar y capacitar a líderes comunitarios que actúen como promotores de hábitos saludables y facilitadores de condiciones de higiene e inocuidad.

P á g i n a | 35

Documento Guía Alimentación Saludable

3.2 ESCUELA – COLEGIO USUARIOS HASTA 5º DE PRIMARIA

LINEAS DE ACCION

ACTIVIDADES

Coordinación intersectorial

Articulación de escuelas saludables y estrategia promocional de estilos de vida saludable.

Integración Curricular

Construcción de contenidos, a ser incluidos en planes curriculares para el fomento de la alimentación saludable (promoción del consumo de frutas y verduras, reducción del consumo de sal, azúcares añadidos y grasas trans).

Concertación, desarrollo y gestión de contenidos (con

Ministerio de Educación Nacional (MEN)

Concertación de metodologías de formación con MEN

Gestionar ante el sector educativo para que se establezca en el PEI, la “Hora del Desayuno”, donde se dedique una vez a la semana, a cada grupo, una clase sobre los alimentos que componen una dieta saludable.

Capacitación docente y bienestar

docente

Concertación con MEN procesos de capacitación docente, para fortalecimiento de la capacidad de identificación de signos de desnutrición o sobrepeso en la comunidad escolar y canalización a Empresas Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB).

Desarrollo de habilidades y conocimientos en el cuerpo docente y directivo durante la rutina escolar, para la promoción de la actividad física y la alimentación saludable.

Apoyo y desarrollo de estrategias de participación de la comunidad escolar (maestros, directivas, padres, alumnos, miembros de la comunidad educativa)

Capacitación a padres y familias

saludables

Desarrollo de estrategias comunicativas y formativas para fortalecer la consolidación de familias saludables.

Apoyo en la construcción de recetarios familiares saludables promovidos desde las escuelas y colegios.

Desarrollo de condiciones y estilos

de vida en el ámbito escolar

Apoyo para fortalecer capacidades en docentes y directivos para asesorar y gestionar condiciones y EVS en el ámbito

escolar.

Participación en la gestión de implementación de tiendas escolares saludables en el ámbito escolar.

Promoción de la inclusión de mayores cantidades de frutas y verduras en las minutas ofertadas por los programas de apoyo y ayuda alimentaria escolar.

Concertar con el sector educativo la implementación de la estrategia de huertos escolares como escenarios de enseñanza y apropiación de hábitos alimentarios saludables.

Identificación de riesgo y gestión para la canalización a la atención de la comunidad escolar

Brindar apoyo para la canalización de casos según riesgo, a la atención oportuna, resolutive y con calidad en los servicios en el marco de la atención primaria en salud (APS).

Las EAPB dirigirán a los escolares remitidos campañas de percepción del riesgo respecto al consumo de sodio,

P á g i n a | 36

Documento Guía Alimentación Saludable
alimentación que contenga grasas trans, azúcares añadidos entre otros y de controles periódicos para lograr un peso saludable

3.3 UNIVERSIDADES Y OTRAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR FORMAL Y NO FORMAL

LINEAS DE ACCION

ACTIVIDADES

Lineamientos para la promoción de

EVS

Coordinación y concertación en el marco de Universidades

Saludables para la inclusión del tema de Alimentación saludable (entorno facilitador para el consumo de alimentos saludables)

Apoyar la gestión para incluir en la consejería universitaria a estudiantes temas sobre promoción del consumo de alimentación saludable.

Dar a conocer el marco normativo y las estrategias poblacionales que se implementan para la promoción de estilos de vida saludable

Implementar la estrategia de puntos de distribución de frutas y verduras en las instituciones académicas.

Implementar los lineamientos para la creación de la sala amiga de la familia lactante en el entorno de la institución universitaria ó de formación superior formal y no formal

Integración Curricular

Identificación de temas y construcción de contenidos en alimentación saludable a ser incluidos en planes curriculares universitarios

Capacitación docente y bienestar docente

Concertación con Ministerio de Educación Nacional y Asociaciones de Facultades para el desarrollo de procesos de capacitación docente, para fortalecimiento de EVS.

Desarrollo de habilidades en el cuerpo docente y directivo durante la permanencia en la universidad, para la promoción y el consumo de alimentos saludables.

Participación en la gestión de implementación de tiendas y

suministros de alimentos saludables

Desarrollo de condiciones y estilos

de vida en el ámbito universitario

Apoyo para fortalecer capacidades en docentes y asesoría a directivos para la gestión de condiciones y EVS en el ámbito universitario.

Apoyo para la creación en el ámbito universitario de un entorno que favorezca la oferta de una alimentación saludable

Identificación de riesgo y gestión para la canalización a la atención de la comunidad escolar

Brindar ayuda para la canalización de casos según riesgo, a la atención oportuna, resolutive y con calidad en los servicios (APS) complementado con campañas de percepción del riesgo respecto al consumo de sodio, grasas trans, azúcares añadidos entre otros.

Página | 37

Documento Guía Alimentación Saludable

3.4 ORGANIZACIONES LABORALES, EMPRESAS

LINEAS DE ACCION

ACTIVIDADES

Lineamientos para la promoción de

EVS

Coordinación, apoyo y concertación en el marco de

organizaciones para la promoción de alimentación saludable creando entornos facilitadores que favorezcan el cambio.

Brindar asistencia técnica para el establecimiento de la consejería universitaria a empleados y usuarios de la organización sobre promoción de la alimentación saludable y el mantenimiento de un peso saludable.

Implementar los lineamientos para la creación de la sala amiga de la familia lactante en el entorno laboral

Gestión para el reconocimiento y exigibilidad de derechos y deberes frente al Sistema.

Colaborar para contribuir con disponibilidad de información útil para la toma de decisiones frente a la elección de una alimentación saludable (difundir mediante afiches, plegables información sobre los beneficios del consumo de frutas y hortalizas, el ABC del sodio y la importancia de reducir las grasas trans en la alimentación)

Implementar la estrategia de puntos de distribución de frutas y verduras a bajo costo en las organizaciones y empresas.

Prevención de riesgos para la salud
promoción de alimentación saludable
de la familia

Brindar apoyo para la realización de jornadas de auto identificación de riesgos de desarrollo de sobrepeso, obesidad, diabetes.

Asesorar para la organización de campañas de percepción del riesgo respecto al consumo de sodio, grasas trans, azúcares añadidos entre otros y de controles periódicos

para lograr un peso saludable

3.5 PRIMERA INFANCIA

LINEAS DE ACCION

ACTIVIDADES

Fortalecimiento de la gestión de
implementación

del

componente

fomento de alimentación saludable

en estrategias de atención integral

(IAMI-AIEPI; de Cero a Siempre)

Participar en la capacitación de talento humano de ET;

EAPB e IPS y ESE

Identificación del riesgo de sobrepeso y obesidad en la
población infantil en las consultas de crecimiento y
desarrollo.

Desarrollo de condiciones y estilos

de vida

Apoyar la implementación de un programa para el fomento
de EVS en primera infancia que incluya el fomento de una
alimentación saludable y la creación de entornos
facilitadores para el consumo para la prevención del
sobrepeso y obesidad infantil.

Gestión para promoción de una

alimentación saludable y como parte

de los EVS

(APS- Atención Integral)

Brindar apoyo en la gestión para el incremento de la disponibilidad, acceso y coberturas de la consejería nutricional con énfasis en la vigilancia del estado nutricional,

la

prevención,

protección

específica,

P á g i n a | 38

Documento Guía Alimentación Saludable

diagnóstico oportuno y atención efectiva temprana

Asistencia

técnica

para

el

fortalecimiento de acciones para la

promoción de alimentación saludable

Apoyar la capacitación en temas clave (promoción del consumo de frutas y verduras, preparación adecuada de alimentos, fomento de la lactancia materna, inicio y composición de la alimentación complementaria, crear entorno familiar e institucional que ofrezca un consumo adecuado de sal, grasas trans, azúcares añadidos y el fomento del consumo de alimentos de alta densidad de nutrientes y bajo aporte calórico), identificación de riesgo en primera infancia, acceso efectivo a servicios,

Campañas de percepción del riesgo respecto al consumo de sodio, grasas trans, azúcares añadidos entre otros y de controles periódicos para lograr un peso saludable

3.6 APS – REORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD, GESTIÓN DE RIESGOS PARA ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

LINEAS DE ACCION

ACTIVIDADES

Regulación de la APS

Inclusión de acciones para el fomento de la alimentación saludable a cargo de los equipos básicos de APS para la identificación de prácticas adecuadas y orientación y consejería para el fomento de la alimentación saludable.

Participación en los procesos de fortalecimiento de los servicios de baja complejidad para la promoción de prácticas de alimentación saludable: promoción de la lactancia materna, el consumo de alimentación completa, equilibrada, suficiente y adecuada para prevenir el sobrepeso, la obesidad y el desarrollo de otras condiciones crónicas.

Organización de campañas de percepción del riesgo respecto al consumo de sodio, grasas trans, azúcares añadidos entre otros y de controles periódicos para lograr un peso saludable

Gestión por el ajuste de las normas técnicas, para la inclusión de acciones que permitan prevenir y controlar el desarrollo de desnutrición, enfermedades carenciales, sobrepeso y obesidad.

Fortalecimiento de acciones

intersectoriales

Apertura de espacios de participación social e intersectorial y articulación de acciones para el fomento de hábitos y

estilos de vida saludables.

Identificación de actores, de formas de participación y de áreas clave de trabajo conjunto

Construcción y difusión de lineamientos que se construyan en el tema de alimentación saludable.

Inclusión de temáticas en estrategias propias de otros sectores que permitan la adopción de hábitos y estilos de vida saludables

P á g i n a | 39

Documento Guía Alimentación Saludable

3.7 NECESIDADES DE INFORMACIÓN

LINEAS DE ACCION

ACTIVIDADES

Alimentación Saludable

Apoyar y contribuir con el proceso de elaboración del protocolo de la Encuesta de consumo de sodio, yodo y fluor 2013

Inclusión

de

preguntas

claves

en

las

encuestas

poblacionales en temas relacionados con los hábitos y costumbres alimentarias de la población respecto al consumo de frutas y hortalizas, sal, grasas trans, azúcares

añadidos y otras prácticas relacionadas con el consumo de nutrientes de interés en salud pública.

Revisión documental sobre metas, plazos y objetivos de la reducción de sodio en alimentos priorizados (Quesos, embutidos, snacks, pan)

Definición de indicadores cumplimiento de los objetivos de reducción en la composición de sal de los alimentos priorizados.

Identificación de estudios, investigaciones o fuentes en las cuales se pueda articular temas de alimentación saludable para la gestión de información y conocimiento en la implementación de los estilos de vida saludable.

Construcción de un documento de plan de acción regional priorizado, validado y ajustado, a partir del lineamiento técnico nacional para la promoción al consumo de frutas y verduras y articulado al plan decenal de salud pública.

Otros estudios y análisis

Análisis de otras opciones y propuestas de inclusión de temas en alimentación saludable y fomento de los estilos de vida saludable.

Recolección y análisis de información disponible (RIPS, Servicios, etc)

3.8 INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN (IEC)

LINEAS DE ACCION

ACTIVIDADES

Estrategias de información a la
comunidad

Integrar los temas de alimentación saludable al Plan A
(consumo de frutas y verduras, consumo de sal, consumo
de grasas trans y azúcares añadidos), como también el
fomento de una alimentación saludable (completa,
equilibrada, suficiente y adecuada).

Apoyar la elaboración de caja de herramientas (cartillas,
afiches, webinars, banners, plegables, folletos informativos
etc) para comunidad en temas clave: infancia, gestación,
adulto mayor, discapacidad, grupos diferenciales,
Socialización de estrategias, campañas y acciones a través
de medios de comunicación masivos, en torno al consumo
de una alimentación saludable.

Estrategias de comunicación para
escuelas y universidades saludables

Identificación de contenidos y gestión para el desarrollo
acorde con la población específica

Estrategias de comunicación para

Asistencia Técnica

Identificación de contenidos y gestión para el desarrollo
acorde con la población específica

3.9 AUTORIDAD SANITARIA, IVC, NORMATIVIDAD

LINEAS DE ACCION

ACTIVIDADES

Gestión en los marcos normativos

Incluir en el Plan Decenal de Salud Pública las metas,
objetivos y actividades a la implementación de la
alimentación saludable en los diferentes entornos que
constituyen una apuesta estratégica para el sector.

Inclusión del tema de alimentación saludable como parte
del fomento de los estilos de vida saludable en los marcos
normativos de APS, PDSP, POS, etc.

Generación y difusión de lineamientos para la promoción
del consumo de frutas y verduras.

Gestión en la generación de guías de atención integral
relacionadas con el tema de alimentación saludable y/o las
enfermedades relacionadas con el consumo de una
alimentación no saludable

Apoyar la gestión que desarrolle la Subdirección de Salud
Nutricional Alimentos y bebidas frente a temas como
etiquetado de alimentos, publicidad de alimentos dirigida a
niños, fomento de la lactancia materna entre otros

Gestión

para
la
adopción
de
indicadores
de
seguimiento
a
resultados en la promoción de la
alimentación saludable

Definición de mecanismos para la gestión de los
indicadores

Monitoreo y evaluación de los indicadores

Página | 41

Documento Guía Alimentación Saludable

3.10 ASESORÍA Y ASISTENCIA

LINEAS DE ACCION

ACTIVIDADES

Capacitación referentes ET y EAPB

Elaboración del perfil de consumo y producción de frutas y
verduras

Articulación con los sectores de agricultura, cultura y
comercio para fortalecer la cadena de producción,

comercialización y consumo de frutas y verduras.

Acompañamiento a la implementación y desarrollo del lineamiento técnico para la promoción al consumo de frutas y verduras.

Alimentación saludable en AIEPI y IAMI

Plan de difusión de los lineamientos para la promoción del consumo de frutas y hortalizas, la estrategia de reducción de sal, la reducción de grasas trans y azúcares añadidos para inclusión en PIC

Detección temprana, manejo y atención para el sobrepeso y la obesidad

Acompañamiento

Alimentación saludable en la Primera Infancia

Gestión para fomento de acciones en promoción de estilos de vida saludable

Consejería nutricional en APS

Implementación de modelos de atención en APS

Implementación de sistemas de información

Seguimiento y evaluación

Seguimiento a indicadores de gestión y de resultado

3.11 INVESTIGACIÓN, FORMULACIÓN Y MONITOREO DE POLÍTICAS

LINEAS DE ACCION

ACTIVIDADES

Estrategia de Reducción de sal

Frente de trabajo Industria y restaurantes

Frente información, educación y
comunicación

Elaborar el Documento técnico de la estrategia

Definir alimentos prioritarios para la reducción del
contenido de sal

Fijar objetivos, metas, plazos de reducción de sodio en
alimentos procesados

Conformación de las mesas de trabajo para cada grupo de
alimentos priorizados

Definir la metodología de trabajo para las mesas
conformadas

Convocar a la industria del catering, restaurantes y escuelas
de gastronomía a participar en la estrategia

Definir con la industria del catering, restaurantes y escuelas
de gastronomía, plan de trabajo del sector para la
disminución del contenido de sodio en preparaciones y

para la creación de un entorno favorable para la
disminución del consumo

Elaborar un plan comunicacional para difundir la estrategia
de reducción del consumo de sodio para la población

P á g i n a | 42

Documento Guía Alimentación Saludable

Investigación

colombiana con el fin de sensibilizar a las diferentes
instancias

gubernamentales,

organizaciones

civiles,

organizaciones privadas y población en general sobre las
acciones desarrolladas a nivel gubernamental, para la
disminución del consumo.

Elaborar el brochure informativo de la estrategia, los
mensajes claves para organizar una campaña de percepción
del riesgo por parte de la población relacionada con los
efectos del excesivo consumo de sodio.

Asesorar líneas de investigación en las áreas de
producción, comercialización y consumo de frutas y

verduras en el país, en conjunto con los Ministerios de Agricultura, Comercio y Cultura.

Participar y asesorar el desarrollo de investigaciones relacionadas con el establecimiento de la línea de base del consumo de sodio, hábitos y costumbres alimentarias de la población colombiana relacionadas con el consumo de sal

Gestionar investigaciones relacionadas con el desarrollo de nuevos métodos y utilización de aditivos para la reducción de la composición de sodio de alimentos elaborados.

Gestionar la elaboración de un documento técnico que contenga el marco normativo y requisitos que deben cumplir los alimentos que se adquieren por parte del estado para asegurar el suministro de una alimentación saludable.

Generación

de

estrategias

de

investigación

aplicada

en

salud

pública para la promoción de la

alimentación saludable en el marco

de los estilos de vida saludable.

Identificación de necesidades

Alianzas con sectores y con instituciones para la obtención de información

Articulación del tema en los sistemas

de información

Gestión para el fortalecimiento de información rutinaria:

RIPS

Concertación de indicadores de morbilidad y de gestión para la promoción de la alimentación saludable como parte de los estilos de vida saludable.

Lineamientos para los actores sobre flujo y uso de información para el fomento de la alimentación saludable y los estilos de vida saludable

Generación de alianzas con actores para la disposición de información útil para el fomento de la alimentación saludable

Vigilancia epidemiológica y en salud pública

Monitoreo a las tendencias de producción y consumo de frutas y verduras en las regiones y el país.

Monitoreo de la composición de los alimentos elaborados priorizados que son objeto de la reducción de sodio (vigilancia de metas, plazos y objetivos de reducción).

Página | 43

Documento Guía Alimentación Saludable

III.

INDICADORES

Meta

Indicador

Tipo

de

Indicador

Periodicidad

Metodología

seguimiento

Responsables

Incrementar anualmente 10% en

el

número

de

puntos

de

distribución y comercialización

de frutas y verduras a nivel

departamental

No.

de

puntos

de

distribución

y

comercialización

de

frutas y verduras a

nivel territorial

Resultado

Anual

Informe anual de

seguimiento

al

incremento en los

puntos

de

distribución

y

comercialización

de frutas y verduras

Ministerio de Salud

y

Protección

Social,

Ministerio

de Hacienda

Incrementar el consumo diario de

frutas en la población de 5 a 18

años por encima del 43% (línea

de base 43%). Fuente: ENSIN

2010

Porcentaje de consumo

diario de frutas en la

población de 5 a 18

años y 19 a 64 años

Resultado

Cada 5 años

Encuesta Nacional

de situación

nutricional

Ministerio de salud
y Protección Social
Ministerio de
Hacienda,
Departamento
Nacional de
Planeación, ICBF,
DANE

Incrementar el consumo diario de
frutas en la población de 19 a 64
años por encima del 41% (línea
de base 41%) Fuente: ENSIN
2010

Incrementar
el
consumo
de
verduras en la población de 5 a
18 años por encima del 12%
(línea de base 12%) Fuente:
ENSIN 2010

Porcentaje de consumo
diario de verduras en la
población de 5 a 18 y 19 a
64 años
Resultado
Cada 5 años

Incrementar
el
consumo
de
verduras en la población de 19 a
64 años por encima del 41%
(línea de base 41%). Fuente:
ENSIN 2010)

Lograr una disminución del
consumo de cloruro de sodio
/persona/día a partir de la línea
de base.

Porcentaje de consumo
de
cloruro
de
sodio/persona/día

Resultado

Cada 5 años

Página | 44

Documento Guía Alimentación Saludable

IV.

REFERENCIAS

Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (DANE). (2005). Censo General 2005.

Ferlay J, Shin HR, Bray F, Forman D, Mathers C, Parkin DM. (Ed.) (2010). Globocan 2008: Cancer Incidence and Mortality Worldwide. IARC CancerBase No.

10.

Recuperado

de

<http://www.iarc.fr/en/publications/eresources/cancerbases/index.php>

Gaviria, A. (2010). Colombia: Tendencias económicas y sociales. Profamilia (2010). En

Encuesta Nacional de Demografía y salud (ENDS). Recuperado de

<http://www.profamilia.org.co/encuestas/Profamilia/Profamilia/images/stories>

/PDF-capitulos/capitulo-2.pdf

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). (2010). Encuesta Nacional de la Situación Nutricional en Colombia - 2010. ENSIN. Colombia.

Ministerio de la Protección Social (MPS) y Universidad de Antioquia, Facultad Nacional de Salud Pública (UDEA). (2010). Análisis de desigualdades e inequidades en salud, Tomo VI. En Análisis de la situación de salud en Colombia 2002-2007.

Recuperado

de

<http://www.minsalud.gov.co/Documentos%20y%20Publicaciones/ASIS-Tomo%20VI--An%C3%A1lisis%20de%20desigualdades%20e%20inequidades.pdf>

Organización Mundial de la Salud (OMS). (2008). Prevención y control de las Enfermedades No Transmisibles: Aplicación de la estrategia mundial. (61

Asamblea

Mundial

de

la

Salud

A61/8).

Recuperado

de

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/A61/A61_8-sp.pdf

P á g i n a | 45

Documento Guía Alimentación Saludable

Organización Mundial de la Salud (OMS). (2011). Informe sobre la situación mundial de

las enfermedades no transmisibles 2010. Resumen de orientación.

Recuperado

de

http://www.who.int/nmh/publications/ncd_report_summary_es.pdf

Organización Mundial de la Salud (OMS). (2011b). Global Atlas on cardiovascular disease prevention

and

control.

Recuperado

de

http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789241564373_eng.pdf

Organización Mundial de la Salud (OMS). (2012a). Enfermedades crónicas y promoción de la salud. Prevención de las Enfermedades Crónicas. Recuperado de

http://www.who.int/chp/chronic_disease_report/part1/es/index4.html

Organización Mundial de la Salud (OMS). (2012b). Informe sobre la salud en el mundo 2002. Reducir los riesgos y promover una vida sana. Washington, D.C

Organización Mundial de la Salud (OMS). (2013). Fomento del consumo mundial de frutas y verduras. En Estrategia mundial sobre régimen alimentario, actividad física y salud. Recuperado de <http://www.who.int/dietphysicalactivity/fruit/es/>

Organización Panamericana de la Salud (OPS) y CEPAL. (2012). El derecho a la salud y los Objetivos de Desarrollo del Milenio. En Naciones Unidas, Objetivos de desarrollo del milenio. Una mirada desde América Latina y el Caribe.

Recuperado de <http://web.undp.org/latinamerica/docs/regionalspanish.pdf>

Robledo Martínez, R. (2010). Las enfermedades no transmisibles en Colombia. En Boletín del Observatorio en Salud, 3: 4. Recuperado de www.revista.unal.edu.co/index.php/bos/article/download/.../18857